

보건복지부 고시 제2026 - 182호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험법 시행령」 제19조제1항 관련 별표2 및 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조제2항에 의한 「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」(보건복지부 고시 제2026-178호, 2026.8.28.)을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2026년 8월 31일

보건복지부장관

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 일부개정고시

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

I. 제3장의 "다339 양전자방출단층촬영(PET)"의 "각 분류항목별 방사성 동위원소"의 "가. 토르소"의 방사선 동위원소의 "(D) F-18 플루시클로빈"란 다음에 "(E) F-18 전립선특이막항원-7.3"란을 다음과 같이 신설한다.

가. 토르소	(E) F-18 전립선특이막항원-7.3 ((별첨) 세부기준 참조)
--------	---

I. 제3장의 "다339 양전자방출단층촬영(PET)"의 "각 분류항목별 방사성 동위원소"의 "마. 부분"의 방사선 동위원소의 "(D) F-18 플루시클로빈"란 다음에 "(E) F-18 전립선특이막항원-7.3"란을 다음과 같이 신설한다.

마. 부분	(E) F-18 전립선특이막항원-7.3 ((별첨) 세부기준 참조)
-------	---

I. 제3장의 "다339 양전자방출단층촬영(PET)"의 "각 분류항목별 방사성 동위원소"의 "바. 토르소 또는 전신촬영 후 재주사 없이 특정부위를 추가촬영"의 방사선 동위원소의 "(D) F-18 플루시클로빈"란 다음에 "(E) F-18 전립선특이막항원-7.3"란을 다음과 같이 신설한다.

바. 토르소 또는 전신촬영 후 재주사 없이 특정부위를 추가 촬영	(E) F-18 전립선특이막항원-7.3 ((별첨) 세부기준 참조)
---	---

I. 제3장의 "다339 양전자방출단층촬영(PET)"의 "(별첨) 세부기준"의 "Ga-68 에도트레오타이드(도타톡) 뇌양전자방출단층촬영의 급여기준"란 다음에 "F-18 전립선특이막항원-7.3 촬영의 급여기준"란을 다음과 같이 신설한다.

구분	세부기준
F-18 전립선 특이막 항원-7.3 촬영의 급여기준	다339 양전자방출단층촬영 (E) F-18 전립선특이막항원-7.3은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인정함. - 다 음 - 가. 급여대상 1) 전립선암의 최초 근치적 치료 전 전이가 의심되는 경우 2) 전립선암으로 이전 치료를 받은 후 혈청 전립선특이항원(PSA) 수치 상승으로 전립선암의 재발이 의심되는 경우 나. Ga-68 전립선특이막항원-11, F-18 전립선특이막항원-1007, F-18 전립선특이막항원-7.3 촬영은 작용기전이 동일하므로 1종만 인정함.

I. 제5장의 "마102 치료적 성분채집술"의 "마102다 치료적 혈장 성분 채집술 급여기준"의 세부인정사항 중 "* (별첨) 참고"를 삭제한다.

I. 제5장의 "마102 치료적 성분채집술"의 "마102다 치료적 혈장 성분 채집술 급여기준"의 (별첨)란을 삭제한다.

부 칙

이 고시는 2026년 9월 1일부터 시행한다.

요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항 신구조문 대비표

현행				개정				비고
항목	제목	세부인정사항		항목	제목	세부인정사항		
I. 행위 제3장 영상진단 및 방사선 치료료				I. 행위 제3장 영상진단 및 방사선 치료료				
다339 양전자방출 단층촬영 (PET)	각 분류항목별 방사성 동위원소	분류항목 가. 토르소	방사성 동위원소	다339 양전자방출 단층촬영 (PET)	각 분류항목별 방사성 동위원소	분류항목 가. 토르소	방사성 동위원소	(제개정 사유) F-18 전립선특이막 항원-7.3 신설
			(1) ~ (D) <생략> <신설>				(1) ~ (D)<현행과 같음> (E) F-18 전립선특이막 항원7.3 ((별첨) 세부기준 참조)	
		마. 부분	(1) ~ (D) <생략> <신설>			마. 부분	(1) ~ (D)<현행과 같음> (E) F-18 전립선특이막 항원7.3 ((별첨) 세부기준 참조)	
		바. 토르소 또는 전신촬영	(1) ~ (D) <생략>			바. 토르소 또는 전신촬영	(1) ~ (D)<현행과 같음>	

현행				개정				비고
항목	제목	세부인정사항		항목	제목	세부인정사항		
		후 재주사 없이 특정부위를 추가촬영	<신설>			후 재주사 없이 특정부위를 추가촬영	(E) F-18 전립선특이막 항원-7.3 ((별첨) 세부기준 참조)	
(별첨 세부기준)				(별첨 세부기준)				(제·개정 사유)
구분	세부기준			구분	세부기준			F-18 전립선특이막 항원-7.3 신설
<신설>	<신설>				다339 양전자방출단층촬영 (E) F-18 전립선특이 막항원-7.3은 다음과 같은 경우에 요양급여를 인 정함. - 다 음 - <u>F-18</u> <u>전립선</u> <u>특이막</u> <u>항원-7.3</u> <u>촬영의</u> <u>급여기준</u> 가. 급여대상 1) 전립선암의 최초 근치적 치료 전 전이가 의심되는 경우 2) 전립선암으로 이전 치료를 받은 후 혈청 전립선특이항원(PSA) 수치 상승으로 전립 선암의 재발이 의심되는 경우 나. Ga-68 전립선특이막항원-11, F-18 전립선특이 막항원-1007, F-18 전립선특이막항원-7.3 촬영 은 작용기전이 동일하므로 1종만 인정함.			

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
I. 행위 제5장 주사료			I. 행위 제5장 주사료			
마102 치료적 성분 채집술	마102다 치료적 혈장 성분채집술 급여기준	1. 마102다 치료적 혈장 성분 채집술은 AABB(American Association of Blood Banks)&ASFA(American Society for Apheresis)의 임상진료 지침* 분류(category) I,Ⅱ에 해당 하는 경우에 인정함을 원칙으로 하되, 다음의 경우는 각 요건을 충족하는 경우에 한하여 요양급여를 인정함. - 다 음 - 가. 이식 환자 1) 신장이식 가) 신장이식 전 탈감작 치료 시	마102 치료적 성분 채집술	마102다 치료적 혈장 성분채집술 급여기준	1. <현행과 같음>	(제·개정 사유) AABB&ASFA 임상진료지침 개정됨에 따라 최신 임상진료지침 반영

현행			개정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
		(1) 항 조직 적합 항원(Anti-HLA antibody) 및 공여자 특이 항체(DSA)인 경우 (가) HLA항체 역가(MFI level) 1,000 이상 시 최대 12회 까지 인정. 단 DSA MFI 에 대한 검사 결과가 없는 상태는 인정하지 아니함 (나) 패널 반응성 항체(PRA) 50% 이상에서 실시한 경 우 20% 이하가 될 때까지 (2) 보체의존 세포독성(CDC) T cell crossmatch(AHG phase) 검사 결과 (가) 양성인 경우 1:16 미만 시 최대 12회까지 (나) 음성이면서 유세포 분석 (flow cytometry) 검사 상 양성인 경우 시행하여 음성이 나타날 때까지				

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
		(3) ABO혈액형 불일치 항체 역가가 1:8 이상인 경우 나) 신장이식 후 (1) 급성 항체매개성 거부반응 (Acute active AMR)인 경우 매일 또는 격일로 최대 12회까지(4주 이내) (2) 만성 항체매개성 거부반응 (Chronic active AMR) 및 재발인 경우 매일 또는 격일로 6회까지 (3) 이식 전 또는 이식 후 신 생검에서 국소성 분절성 사구체신염으로 확진된 환자에게 이식 후 단백뇨가 재발된 경우 최초 3일은 매일 1회씩, 그 이후부터는 2주 동안 6회 (총 9회) 인정 (4) ABO혈액형 불일치 항체 역가				

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
		가 1:16 이상으로 상승한 경우 2) 심장이식 가) 심장이식 전 탈감작 치료 시 패널 반응성 항체(PRA)가 50% 이상 확인된 경우 5회 까지 나) 심장이식 후 급성 항체매개성 거부반응(Acute active AMR) 이 진단된 경우 5회까지 3) 폐 이식 가) 폐이식 전 탈감작 치료 시: 패 널 반응성 항체(PRA) 50% 이 상에서 시행하는 경우 6회까지 나) 폐이식 후 (1) 급성 항체매개성 거부반응 (Acute active AMR)이 진 단된 경우 6회까지 (2) 공여자 특이 항체(DSA)가 있고 폐기능 저하가 동반 된 경우 6회까지				

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
		다) 공여자 특이 항체(DSA)가 있고 HLA항체 역가(MFI level) 나. 간질환 1) ABO혈액형 부적합 간이식에서 탈감작 목적 또는 수술 후 급성 항체 매개성 거부반응의 발생 위험이 있다고 판단되고 동종 응집소항체역가 1:16 이상으로 상승된 경우에 실시 시 최대 15회까지 (1개월 이내) 2) 간이식 혹은 간절제술 후에 발생한 급성 간기능 부전의 경우 3회까지 인정하며, 인정횟수 초과 시 「선별급여 지정 및 실시 등에 관한 기준」에 따라 본인부담률을 50%로 적용 다. 신경계 질환 1) 급성 염증성 탈수초성 다발성신경병증 (AIDP): 매일 또				

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
		는 격일로 실시하며 6회까지 인정하되, 동 치료를 하면서 투여한 아이비글로부린은 인정하지 아니함 2) 만성 염증성 탈수초성 다발성신경병증 (CIDP): 주 2~3회 실시시 인정 3) IgG, IgA, IgM 부단백질 탈수초성 다발신경병증: 매일 또는 격일로 실시하며 6회 까지 4) 급성 전파성 뇌척수염(ADEM): 매일 또는 격일로 실시하며 6회까지 5) 다발성 경화증: 매일 또는 격일로 실시하며 7회까지 라. 혈전성 미세혈관병증(TMA) : 혈전성 혈소판감소성 자반증(TTP) 또는 비정형 용혈성 요독증후군(aHUS)을 의심하여 확진을 위한 검사 후 응급으				

현 행			개 정			비고
항목	제목	세부인정사항	항목	제목	세부인정사항	
		로 시행한 경우에 인정 마. 중증열성혈소판감소증후군을 진단 받은 자 중 중증의 환자에게 시행한 경우에 구체적인 의사소견서 및 관련 자료를 참조하여 인정 2. 상기 1.에서 언급되지 아니한 AABB & ASFA의 임상진료지침 분류(category) III에 해당하는 경우는 의사소견서 및 관련 자료를 첨부하여 임상적 필요성을 입증한 경우 사례별로 입증함 * (별첨) 참고 (별첨) AABB(American Association of Blood Banks) & ASFA(American Society for Apheresis)의 치료적 혈장 성분채집술 임상진료지침			2. <현행과 같음> * (별첨) <삭제> (별첨) <삭제>	

현행				개정			비고
항목	제목	세부인정사항		항목	제목	세부인정사항	
		Category	Indication	Modifying Conditions	Typical Course Number of treatments		
		I	국소 분절 사구체 경화증	신이식 재발	매일 또는 격일 (변동)		
			용혈성 요독 증후군	H항체 인자	매일 (변동)		
			고점도 단일클론 감마병증	증후 리튬사망 예방	매일 (1~3회)		
			간이식, ABO부적합	생존 공여자 탈감작	매일 또는 격일 (변동)		
			급성 염증성 탈수초화(길랑-바레)		격일 (5~6회)		
			항호중구세포질항체 관련 급속 진행 사구체 신염(과립중증)	투석 의존 심장장애	매일 또는 격일 (6~9회)		
			사구체 기저막 질환	투석 비의존 심장장애	매일 또는 격일 (7~10회)		
			만성 염증성 탈수초화 다발성 근병증		주 2~3회 (변동)		
			냉동글로불린혈증	증후/중증	격일 (3~8회)		
			중증근무력증		격일 (3~7회)		
			부단백질 탈수초화 다발신경병증	IgG/IgA/IgM	격일 (5~6회)		
			연쇄상구균 감염과 관련된 소아자가면역 신경정신 장애, 시토탄무도병		격일 (5~6회)		

현행				개정			비고
항목	제목	세부인정사항		항목	제목	세부인정사항	
		Category	Indication	Modifying Conditions	Typical Course Number of treatments		
			신장이식, ABO적합	항체 매개성 거부반응 생존 공여자 탈감작 공여자 특이적 HLA항체 양성	매일 또는 격일 (5~6회)		
			신장이식, ABO부적합	생존 공여자 탈감작	매일 또는 격일 (변동)		
			혈전성 미세 혈관 병증, 약물관련	Ticlopidine	매일 (변동)		
			혈전성 혈소판 감소성 자반증		매일 (변동)		
			월경병		매일 또는 격일 (3~5회)		
		II	급성 전파성 뇌척수염		격일 (3~6회)		
			자가면역 용혈성빈혈	심한 냉응집병	매일 또는 격일 (변동)		
			치명적인 항인지질 증후군		매일 (3~5회)		
			가족성 고콜레스테롤혈증	소혈량 동형접합	매주 (무기한)		
			조혈모세포이식, ABO 부적합		매일 (1~3회)		

현행				개정			비고
항목	제목	세부인정사항		항목	제목	세부인정사항	
		Category	Indication	Modifying Conditions	Typical Course Number of treatments		
			용혈성 요독증후군	유전자 돌연변이	매일 (변동)		
			램버트이튼 근시증후군		매일 또는 격일 (변동)		
			다발성 경화증	급성 신경계 염증성 탈수 초화	격일 (5~7회)		
			골수종 캐스트 신장병		매일 또는 격일 (5~7회)		
			시신경척수염(데빅 증후군)	급성	매일 또는 격일 (변동)		
			과다복용, 발작 및 중독	버섯 중독	매일 (변동)		
			피탄산 저장질환 (Fefsum disease)		매일 또는 격일 (변동)		
			신장이식, ABO부적합	항체 매개성 거부반응	매일 또는 격일 (변동)		
			전신성 홍반성 루프스	중증	매일 또는 격일 (3~6회)		
			전압-게이트된 칼륨채널 복합체		격일 (5~7회)		